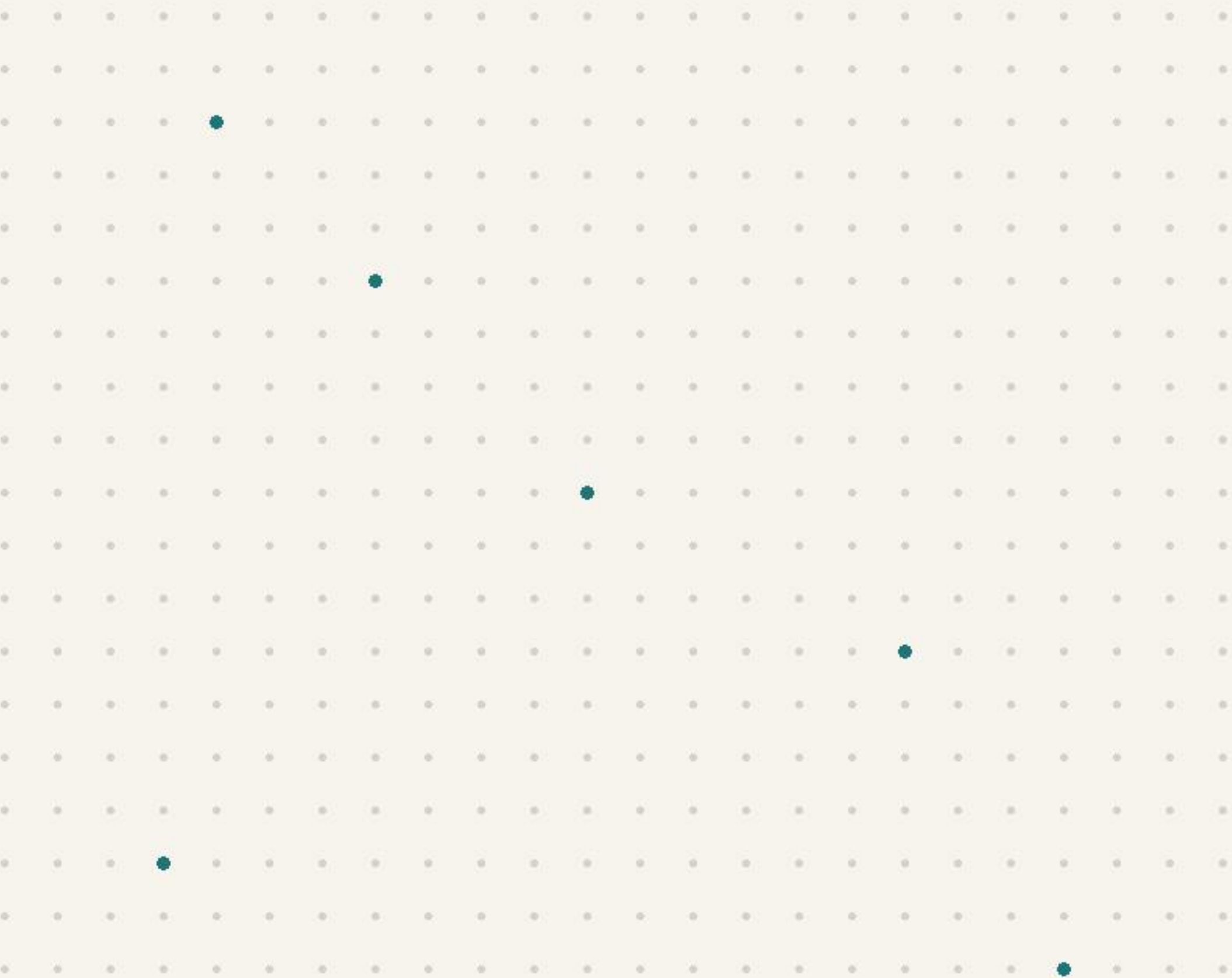




Contar UBS nao basta.

Eu cruzei cadastro, território, APS, CNES e SIA/SUS para entender onde o número bruto começa a falhar.

47.710

registros de UBS

O primeiro erro seria parar aqui. Registro de unidade é uma camada de estrutura, não uma medida direta de acesso.

CADASTRO

TERRITORIO

APS

CNES

SIA

cada camada tira um pouco da ingenuidade da leitura

91,6%

caem dentro do município declarado



43.717 pontos consistentes

2.062 fora do polígono municipal

Latitude e longitude plausíveis ainda podem apontar para o município errado. Por isso entrei com malha municipal do IBGE e point-in-polygon.

CNES/ST

91,3%



SIA/PA em 3 competencias

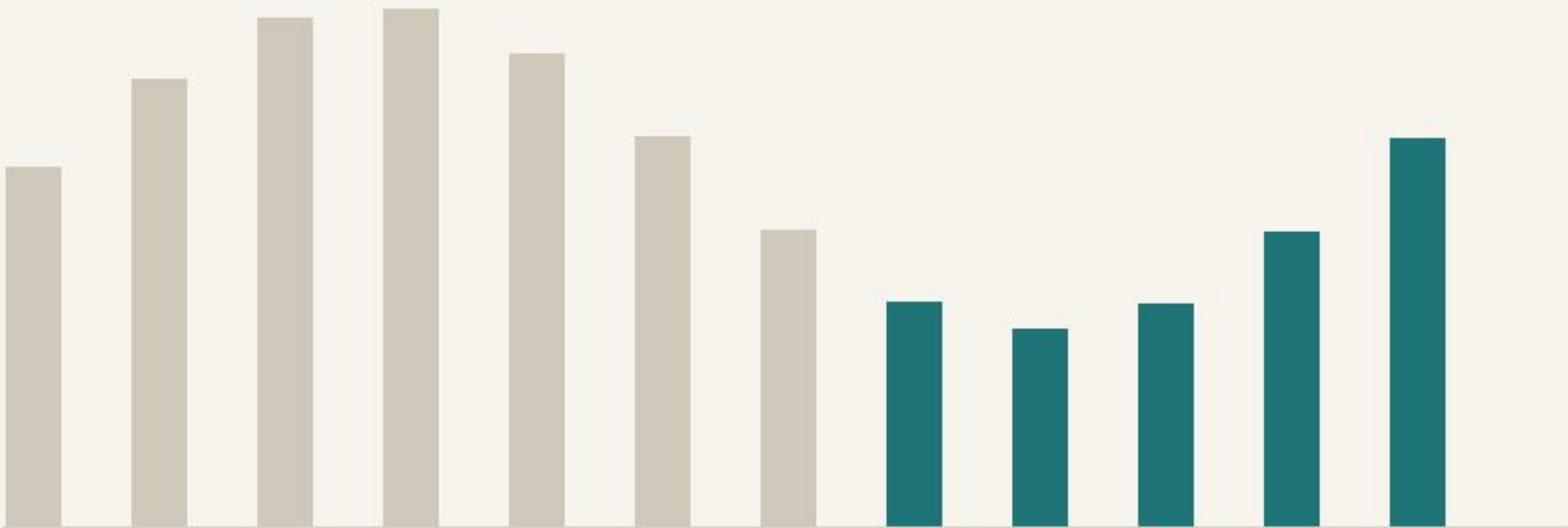
23,8%



11.333 unidades combinam presença cadastral recente com produção ambulatorial registrada. Isso é sinal, não veredito.

98,9%

APS ponderada por população



Cobertura acima de 100% não vira acesso real por magia. No projeto eu guardo a leitura nominal e também a leitura capada.

5 camadas



UBS / populacao

componente do score



gap APS

componente do score



atividade recente

componente do score



qualidade espacial

componente do score



vulnerabilidade territorial

componente do score

A vulnerabilidade aqui ainda é proxy territorial. Renda, saneamento e pobreza entram numa próxima versão.

Top UFs no índice



DF, SP e RJ aparecem no topo do cenário balanceado e continuam altos quando eu mudo os pesos. Isso não fecha diagnóstico, mas aponta onde investigar primeiro.

O que o dado ainda nao sabe

- ☐ equipe ativa por escala
- ☐ tempo real de deslocamento
- ☐ qualidade do cuidado
- ☐ vulnerabilidade social direta

Mesmo assim, sair de uma contagem simples para uma base cruzada já muda a conversa. O repositório tem dados, código, gráficos e testes.

github.com/luandarodrigues/luandarodrigues